جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : مرسيل طلعت رزق يوسف
المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** امبابه **العنوان :** ---------
رقم البطاقة : 28704272103464 **رقم التليفون :** 01277725754 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 21-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 27-04-1987 **المهنة :** حاصل علي دبلوم

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: مرسيل طلعت رزق يوسف
National ID: 28704272103464

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

مرسيل
طلعت رزق يوسف
٢٦ ش الكفر-ابن الرشيد
روض الفرج - القاهره

٢٨٧ ٠٤ ٢٧ ٢١ ٠٣٤ ٦٤

LN4243517

٢٨٧٠٤٢٧٢١٠٣٤٦٤ ٢٠٢٥/١٢
حاصلة على دبلوم فنى تجارى

انثى مسيحية متزوجة
مينا لطيف صادق سعيد حنا
البطاقة سارية حتى ٢٠٣٢/١٢/٠٩


جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية
مرسيل
طلعت رزق يوسف
٩ ح العدل-ش البوهى-المنيرة
امبابه - الجيزه
٢٨٧ ٠٤ ٢٧ ٢١ ٠٣٤ ٦٤
HV5012837


٢٨٧٠٤٢٧٢١٠٣٤٦٤
٢٠١٨/١٢
حاصلة على دبلوم فنى تجارى
انثى
مسيحية
متزوجة
مينا لطيف صادق سعيد حنا
البطاقة سارية حتى ٢٠٢٥/١٢/٢٥

Name: مرسيل طلعت رزق يوسف **MR. :** 7314	

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient has a history of left-sided breast cancer, clinical stage CT2, estrogen receptor positive (ER 8/8), progesterone receptor positive (PR 7/8), HER2-negative. Neoadjuvant chemotherapy was completed on 29 June 2022, followed by left breast-conserving surgery with pathology showing ypT2, ypN0. Adjuvant therapy includes Zoladex and Femara initiated in September 2022; Zoladex was scheduled for a three-month course with a due date of 6 April 2026, and Femara is planned through August 2025.

The patient's next scheduled mammogram (SM) is in August 2026, with the most recent prior mammogram performed in March 2026. Imaging today demonstrated a bright liver, which is being monitored while the patient continues Femara. Pharmacy refill for Femara is arranged for the next two months, and the next Zometa dose is planned for July 2026.

The patient presented today for continuation of Femara and supportive care. Pharmacy refill for Femara is arranged for the next two months, and the next follow-up visit is scheduled for 19 November 2026.

تحريرا في ,

التاريخ :	**21-09-2026**	**الوقت :**	

الطبيب المعالج : dina makram

يعتمد ,

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM

14/8/2022

Name	مرسيل طلعت رزق	MRN	١٢/٠٠٢٢
Age	٣٥٤٠	ID	٢٨٧٠٤٢٧٠٤٣٤
Menopausal status		Phone	٠١٢٧٧٢٥٧٥٤
OCP		marital status	
Co morbidity		Familyhistory	٠١٢٨٩٤٠٥٤٣

Clinical Data

Bx: IDC G II

ER:	PR:	HER 2:	KI67:
8/8	7/8	- ve	25%

Sonomammography :

Mets Workup:

1m & CT2- No.

R L

left BCS + SLNBx

TNM

29-6-2022

Recommendations:

- Post NACT (FAC x 4 → TAXOL x 3).
- pT2, pNo - Combined mucinous & IDC G II
- Free LNs (0/4)
- Free margins.

MDT OUTCOME & PLAN

- For PORT
- AI + Zoladex
- Proka. 16ms

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY
SIGNATURE			

Name :Marsel Talaat rezk

Date : 12-1-2022

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

** Given history of breast cancer.

1. *Chest:*
   - No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
   - No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
   - No evidence of pleural effusion.
   - Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
   - Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
2. *Abdomen and pelvis:*
   - The liver is enlarged with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
   - Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
   - No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
   - Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
   - Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
   - Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
   - Under filling of the urinary bladder.
   - IUD is seen in place.
   - Normal appearance of the other pelvic organs.
   - No abdominal or pelvic lymphadenopathy or collections.
   - No suspicious lytic or sclerotic bone lesions.

OPINION:

- No CT evidence of pulmonary or hepatic metastatic deposits.

Dr. M. Gomaa, M.D.

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

مثال ١٢

tient Name	: الأستاذه / مرسيل طلعت رزق	Request No.	: 132088
atient No.	: 28704272103464	Request Date	: 12/12/2021
Path No.	: 3077/21	Verification Date	: 01/01/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 34 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: marwa mohamed yo

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
Lt breast mass
Nature of the specimen:
Tru cut biopsy

Gross Examination:
Multiple gray white tissue cores up to 1.5 cm, totally submitted. Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

Microscopic examination:
- Histological type: IDC
- Grade II
- Angioinvasion: no
- Ductal carcinoma in situ: no
- Additional pathologic findings: focal mucinous activity

Diagnosis:
Lt breast mass, tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma GII
Biomarkers:
ER: Strong nuclear reaction in 80% of tumor cells (Allred score 8/8)
PR: moderate nuclear reaction in 75% of tumor cells (Allred score 7/8)
Her-2: weak incomplete membrane reaction in 10% of tumor cells (score 1+), Negative.
Ki 67: 25 % nuclear reaction

Verified by :
Walaa ghoniem

غرفة رقم (6) – الدور الأول – مبنى رقم (937) – كورنيش النيل – شبرا القبة – القاهرة – مصر
Room No. (6) - First Floor-Building No. 937- Nile Corniche - Shubra El Qobba - Cairo, Egypt

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab

المبادرة الرئاسية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

Patient Name	: الأستاذه / مرسيل طلعت رزق	Request No.	: 13004272
Patient No.	: 28704272103464	Request Date	: 29/06/2022
Path No.	: 1876/22	Verification Date	: 23/07/2022
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 34 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc :		Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data : Left breast cancer
Nature of the specimen : Left BCS & SLN biopsy
Gross Examination:
- Procedure: Left BCS specimen measured 9x6.5x2.5 cm with covering skin ellipse measured 6 x 0.5 cm .
- Tumor extent : An ill defined greyish white firm mass measured 2.2x1.5x1.5 cm .
- Distance from margins: 0.8 cm away from inferior margin , 2 cm away from deep margin, 0.5 cm away from inferior margin.
- Lymph nodes number and size: 4 SLNs up to 3.5x1.5 cm .
- Frozen section: Free margins & Free SLNs (0/5)

Microscopic examination:
- Histological type: Combined Mucinous & Invasive duct carcinoma NST
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Ductal carcinoma in situ: No
- Angioinvasion: No
- Perineural invasion: Yes
- Lymph node involvement: Free SLNs (0/4)
- Resection Margins: Free margins

Diagnosis:
Left BCS & SLN biopsy:
Combined Mucinous & Invasive duct carcinoma NST , Grade II
- Free LNs (0/4)
- Free margins
- Stage : pT2 ; pN0

Prof. Dr. Gamal Abdelatty Dr.Samah Sayed

Verified by :
saamah sayed

غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر
Room No. (4) - First Floor Building No. 987 - Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

MARSAL, Patient ID: 122016033 DOB: 27-Apr-1987 Date: 20-Aug-2022

Lastname: TALAL
Firstname: MARSAL
Patient ID: 122016033
Patient ID: 306848
Date of Birth: 27.04.1987

Procedure: 70030, Bone Scan
Medical Question:
Clinical Comment:

========== REPORT TEXT ==========

99mTc MDP Bone Scan Report
* Whole Body Anterior and Posterior Planar Views Acquired 2Hrs. Post I.V Injection of 20mCi of 99mTc MDP Revealed:

" No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.
" Degenerative changes are noted over the dorso-lumbar vertebrae.
" Arthritic changes are noted over both shoulder and both knee joints.
" Both kidneys are visualized.
Conclusion:
" No definite evidence of active osseous deposits could be seen over the surveyed skeleton.

Much Obliged.
Dr. Nada Fadl

========== REPORT TEXT ENDE ==========